

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 1 de 14

**PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES
RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUÍDOS CORPORALES DE
RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE
SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL.**

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: EU Sandy Guajardo	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Enfermera IAAS	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 22-08-2025	Fecha: 01-09-2025	Fecha: 09-09-2025
Firma:  Sandy Guajardo Padilla R.U.T.: 18.750.793-6 ENFERMERA	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 2 de 14

I. INTRODUCCIÓN.

El personal que se desempeña en las organizaciones prestadoras de salud, se encuentra expuesto al igual que los trabajadores de otras áreas a numerosos riesgos, sin embargo la diferencia en el personal sanitario lo constituye el riesgo biológico, que se relaciona principalmente, con infecciones que puede adquirir derivadas de la atención de salud y/o el riesgo de exposición a sustancias potencialmente tóxicas, que se relacionan eventualmente con patologías derivadas del uso de productos químicos, utilizados en procesos diagnósticos, terapéuticos y en prevención y control de IAAS.

II. ALCANCE.

Este protocolo es aplicable a todo funcionario/a del CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo, Postas de Salud Rurales y Estación Médico Rural independiente de su calidad contractual (permanente o transitoria) y quienes realizan actividades docente-asistenciales que estén en contacto con fluidos corporales y/o material corto punzante dentro de los establecimientos de salud de la comuna de Peralillo.

III. OBJETIVOS.

1. Objetivo General:

Manejar adecuadamente los procedimientos ante accidentes relacionados con sangre o fluidos corporales de riesgo en CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo, Postas de Salud Rurales y Estación Médico Rural.

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 3 de 14

2. Objetivos específicos:

- Estandarizar las conductas del equipo de salud a seguir en caso de sufrir accidentes laborales relacionados con sangre o fluidos corporales de riesgo.
- Indicar los tipos de registros implementados de los accidentes ocurridos.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Jefatura directa del personal afectado: Encargada de informar a Dirección CESFAM sobre incidente. Prestar ayuda inmediata al funcionario si lo necesita. Dar facilidades para que el funcionario/a afectado pueda asistir a mutualidad asociada.

Servicio urgencia rural (SUR): Otorgar atención a los funcionarios que han sufrido accidentes con exposición a fluidos corporales de alto riesgo. Realizar DAU.

Director CESFAM: Encargado de completar DIAT y enviar copia al Departamento de Salud y Comité paritario para inicio de investigación.

Personal CESFAM, Postas y EMR: Conocimiento y utilización de las medidas de protección personal. Conocimiento del manejo inmediato de exposición a fluidos corporales. Responsable de dar aviso de incidente a Jefe Directo. Podrá informar a Director sobre incidente.

V. DEFINICIONES.

SUR: Servicio de urgencia rural.

PSR: Corresponde a Postas de Salud Rural dependientes de Departamento de Salud I. Municipalidad de Peralillo: Posta Población, Posta Los Cardos, Posta Calleuque.

EMR: Estación Médico Rural, correspondiente a Rinconada de Molineros.

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 4 de 14

IAAS: Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.

DIAT: Declaración Individual de Accidente del Trabajo (anexo 1).

DAU: Dato de urgencia.

PERSONAL EXPUESTO: Se describen 2 tipos:

- Aquel trabajador de la salud que ha sufrido punción o corte con aguja o material cortopunzante o aquel que ha estado expuesto en forma significativa en piel no indemne o mucosas, a sangre y/ o fluidos corporales de alto riesgo biológico.
- Aquel trabajador que ha tenido exposición a agentes microbiológicos de transmisión por aerosoles, gotitas o contacto directo o indirecto sin medidas de protección.

FLUIDO DE ALTO RIESGO BIOLÓGICO: Son todos los fluidos corporales que efectivamente se asocian a la transmisión de los patógenos sanguíneos, como sangre, secreciones genitales, líquidos de cavidades normalmente estériles y cualquier otro fluido, secreción o excreción con sangre visible.

PACIENTE FUENTE: Corresponde a aquel paciente que es el origen del fluido involucrado en un accidente con exposición.

RIESGO BIOLÓGICO: Corresponde a la exposición ocupacional de microorganismos u otros seres vivos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, reacción alérgica o toxicidad.

VI. DESARROLLO.

1. Medidas de prevención frente a exposición a fluidos corporales de alto riesgo y manejo post exposición.

Las precauciones estándar, corresponden al conjunto de medidas destinadas a minimizar el riesgo de transmisión de cualquier microorganismo entre el personal y los usuarios. Consisten en la incorporación de conductas y la utilización de mecanismos de barrera como elementos de protección por parte del personal clínico y se encuentran definidos en los protocolos de

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 5 de 14

Gestión Clínica (GCL). Estos mecanismos son suficientes para prevenir la transmisión al equipo de salud y no requieren de otras medidas especiales.

2. Recursos para la eliminación de objetos corto-punzante

CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo, PSR y EMR, cuentan con contenedores de cartón reforzadas y plásticas de color amarillo, para la eliminación de objetos cortopunzantes, que están dispuestas en todas las áreas clínicas según norma REAS.

Por ningún motivo los objetos cortopunzantes serán eliminados en bolsa de basura común, debido el riesgo de accidentabilidad del personal que recolecta la basura.

3. Otras medidas generales para evitar accidentes con objetos contaminados

- ✓ No se recapsularán las agujas hipodérmicas independiente del uso que tuvieron.
- ✓ No se desmontarán agujas de sutura, bisturís y otros, con las manos directamente. Para tal efecto se utilizarán portaagujas o pinzas Kelly 14 o 16 cm.

4. Clasificación de la exposición.

a) Exposición con Riesgo:

- Herida profunda que causa sangramiento, provocada por instrumento con lumen lleno de sangre u otro fluido corporal de riesgo, o a simple vista contaminada con sangre u otro fluido corporal de riesgo.
- Exposición de mucosas o herida a sangre u otro fluido corporal de riesgo, o a simple vista contaminado con sangre.
- Derrame de sangre u otro fluido corporal de riesgo en una solución de continuidad de la piel (herida).

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 6 de 14

B) Exposición sin Riesgo:

- Herida superficial, que no causa sangramiento o escarificación.
- Herida con instrumento que no está a simple vista contaminado con sangre u otro fluido corporal de riesgo.
- Exposición de piel intacta o indemne a sangre u otro fluido corporal de riesgo.

5. Procedimiento para manejo inmediato del personal que sufre accidente laboral cortopunzante o con exposición en mucosas.

5.1. CESFAM Dr. Orlando Leyton A Peralillo, PSR, SUR, EMR horario hábil.

Si el funcionario sufre con ocasión de su trabajo, un accidente laboral cortopunzante o exposición a fluidos de alto riesgo, se deben cumplir los siguientes pasos:

Manejo Inmediato:

1. Lavado de la herida con abundante agua corriente y jabón en sitio de la lesión o zona de exposición al fluido.
2. Aplicar solución antiséptica de alcohol al 70%.
3. En caso de exposición en mucosa ocular o nasal realizar irrigación profusa con agua corriente o suero fisiológico. En caso de mucosa oral realizar enjuague con agua corriente o clorhexidina 0.12.
4. Informar a Jefe directo sobre accidente. El jefe directo o el mismo funcionario pueden informar a Dirección CESFAM sobre el suceso.
5. El funcionario/a deberá dirigirse a SUR donde se realizarán los primeros auxilios según corresponda y se realizará DAU.
6. Funcionario/a se dirige a Dirección CESFAM para completar notificación DIAT.
7. Finalmente con hoja DAU y DIAT el funcionario/a podrá dirigirse a la mutual de seguridad para la evaluación en esta institución.

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 7 de 14

5.2. En personal CESFAM, SUR, en horario posterior a las 17:00 hrs y fines de semana- festivos.

Si el funcionario sufre con ocasión de su trabajo, un accidente laboral cortopunzante o exposición a fluidos de alto riesgo, se deberá cumplir los siguientes pasos:

Manejo Inmediato:

1. Lavado de la herida con abundante agua corriente y jabón en sitio de la lesión o zona de exposición al fluido.
2. Aplicar solución antiséptica de alcohol al 70%.
3. En caso de exposición en mucosa ocular o nasal, realizar irrigación profusa con agua corriente o suero fisiológico. En caso de mucosa oral realizar enjuague con agua corriente o con clorhexidina 0.12.
4. Informar a médico de turno SUR, quien debe asistir si la categorización de la urgencia es C1-C2 o C3. Si es C4 o C5 podrá realizar la intervención el TENS de SUR. Se realiza en este momento el DAU.
5. Al día hábil siguiente debe informar del accidente a jefe directo y a Director CESFAM, quien realizará el DIAT.
6. Con los documentos de DAU y DIAT el funcionario/a puede presentarse en mutual de seguridad para inicio de tratamiento.

5.3. Pasos a seguir en el personal según modalidad de contrato y alumnos/as en práctica.

En el caso de las personas contratadas en modalidad de plazo fijo, reemplazo y contrato indefinido, se ejecutarán los pasos descritos anteriormente, ya que en estos casos el contrato va asociado al seguro por mutual.

El en caso de funcionarios contratados con prestación de servicios se deberán realizar los pasos antes señalados, hasta la constatación de lesiones en SUR, donde se realizará DAU. Con este documento se da aviso a jefe

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 8 de 14

directo sobre el accidente y la Dirección de CESFAM otorgará los permisos para que el funcionario/a se dirija a la institución que está asegurado.

En el caso de los alumnos/as que estén realizando su práctica en CESFAM, PSR, SUR o EMR, y sufran un accidente laboral cortopunzante o exposición a fluidos de alto riesgo, se deben cumplir los siguientes pasos:

Manejo Inmediato:

1. Lavado de la herida con abundante agua corriente y jabón en sitio de la lesión o zona de exposición al fluido.
2. Aplicar solución antiséptica de alcohol al 70%.
3. En caso de exposición en mucosa ocular o nasal realizar irrigación profusa con agua corriente o suero fisiológico. En caso de mucosa oral realizar enjuague con agua corriente o clorhexidina 0.12.
4. Informar a profesional tutor y docente guía sobre accidente.
5. El alumno/a deberá dirigirse a SUR donde se realizarán los primeros auxilios según corresponda y se realizará DAU.
6. El alumno/a según convenio de la universidad/ instituto se dirigirá a las diversas instituciones según seguros vigentes.

6. Seguimiento del accidente.

Cada funcionario/a, alumno/a en práctica independiente de la modalidad de contrato es responsable de mantener sus controles según indicaciones otorgadas por el médico de la institución que esté afiliado. Departamento de salud otorgará los permisos necesarios al personal para que se realicen los tratamientos y controles necesarios hasta el momento del alta.

7. Medidas de prevención para el personal de salud.

a) Prevención de TBC en personal de riesgo.

Corresponde a personal en riesgo de TBC a funcionarios/as y alumnos/as en práctica de las carreras de la salud, que están en contacto con

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 9 de 14

pacientes bacilíferos, sin utilización correcta de las medidas de aislamiento respiratorio.

Actividades:

- **Previo al ingreso por primera vez a atención salud primaria el nuevo funcionario/a** deberá traer un certificado de salud compatible con el cargo realizado en un Hospital público y firmado por médico. En este examen el hospital debe realizar una anamnesis, examen físico - pesquisa de cicatriz de BCG y radiografía de tórax.
- **Examen preventivo anual a personal de riesgo definido: Manejo de Personal con sospecha de TBC pulmonar.**
 - Control con Médico morbilidad.
 - Toma de baciloscopías de expectoración y radiografía de tórax.
 - Restricción de contacto con pacientes hasta resolución del cuadro.

b) Inmunizaciones para el personal.

El MINSAL provee, a través de programas específicos para el personal más expuesto, las vacunas Antiinfluenza y AntiHepatitis B. Por otra parte, cuando existe alerta epidemiológica en la comunidad, por un aumento inusual de casos de enfermedades transmisibles, se hace extensivo el programa de inmunizaciones al personal de la salud, como ha sido el caso de rubéola, sarampión y Coqueluche y COVID19 en los últimos años.

c) Vacuna antiinfluenza.

Para la vacunación antiinfluenza del personal se han definido los servicios y unidades clínicas, como obligatoriedad en el programa del establecimiento, esperándose coberturas iguales o superiores al 85%.

Responsables:

Enfermera Encargada PNI: Programar, coordina, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa. Se coordinarán con Dirección de CESFAM para comenzar campaña y llamar a los funcionarios a fin de realizar inmunización.

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 10 de 14

La evaluación final de la Campaña antiinfluenza será enviada en cada corte por los referentes regionales.

d) Programa de vacunación antihepatitis B del personal.

Se incluyen en el Programa de vacunación antihepatitis B a los funcionarios clínicos, con calidad jurídica titular, contrata o reemplazante, el esquema completo que considera 3 dosis (0- 1- 6 meses), el cual otorga protección mayor al 95% en la mayoría de los individuos inmunocompetentes.

A todo funcionario vacunado se le entregará un carné de Vacunación Hepatitis B, donde se registrará la fecha de administración de la 1° dosis y fechas de citación para la próximas dosis y responsable de la administración de cada dosis, hasta completar el esquema.

- e) **Otras inmunizaciones:** En los casos que exista alerta epidemiológica en el país y el Ministerio de Salud disponga la vacunación masiva de grupos específicos, que incluyan al personal sanitario, será obligatorio la inmunización de acuerdo a las especificaciones técnicas que correspondan en ese momento.

VII. SOBRE ANÁLISIS GLOBAL DE CASOS.

La Dirección de CESFAM enviará copia vía correo electrónico de DIAT a Departamento de Salud: Unidad de RRHH y a Comité paritario. Este Comité procederá a realizar la investigación de incidentes mediante entrevista a las personas involucradas, donde se describirá el incidente/accidente, causas inmediatas, causas básicas. Finalmente se establecen instrucciones para evitar el riesgo con responsables y plazos (anexo 2).

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 11 de 14

VIII. REGISTROS.

A continuación se presentan los registros a utilizar para garantizar el correcto manejo de presente protocolo:

Nombre del documento	Entidad que realiza llenado de documento	Custodia	Recuperación	Retención
Hoja DAU	Personal SUR	SUR	Por RUN y nombre	1 año.
Hoja DIAT	Dirección CESFAM	Dirección	Por RUN y nombre	1 año.
Formulario investigación incidente	Comité paritario	Comité paritario	Por RUN y nombre	1 año.

IX. DISTRIBUCIÓN

Dirección del CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo.

Unidad de Calidad y seguridad del usuario.

Encargada REAS

Encargada IAAS

Todos los funcionarios/as de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo,
EMR Rinconada de Molineros y Postas de Salud Rurales Población,
Los Cardos, Calleuque.

Servicio de Urgencia Rural (SUR)

X. REFERENCIAS.

Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis, Universidad de Chicago septiembre 2013, vol. 34, no.9.

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 12 de 14

Manual de Prevención y Control de IIH, Hospital Dr. Hernán Henríquez A., 2008.

Decreto Exento N° 561 del 7 de Marzo de 2000 que aprueba Norma Técnica N° 48 del Ministerio de Salud, "Norma de manejo pos-exposición laboral a sangre en el contexto de la prevención de la infección por VIH".

XI. AUTORES.

Sandy Guajardo, Enfermera Encargada IAAS.

XII. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 13 de 14

XIII. ANEXOS

Anexo 1: Hoja DIAT

DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO (DIAT)			
 Código del Caso	 Fecha de Emisión	Folio:	
A. Identificación del Empleador			
 Nombre o Razón Social		 RUT	
 Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad)		 Comuna	 Número de Teléfono
 Actividad Económica		☐ Hombres ☐ Mujeres	☐ Pública ☐ Privada
☐ Principal ☐ Contratista ☐ Subcontratista ☐ De Servicios Transitorios Tipo de Empresa		Nº de Trabajadores Propiedad de la Empresa	
Si es Contratista o Subcontratista, señale actividad económica empresa principal:			
B. Identificación del Trabajador/a			
 Nombre - Apellido Paterno - Apellido Materno		 RUT	
 Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad)		 Comuna	 Número de Teléfono
☐ Hombre ☐ Mujer Sexo	 Edad	Señale si el trabajador pertenece o no a un pueblo originario: ☐ Aikeche ☐ Colla ☐ Quechua ☐ Otro -Cuál?	
 Nacionalidad		 Fecha de Nacimiento	
☐ Indefinido ☐ Pazo Fijo ☐ Por Odra o Fianza ☐ Temporada Tipo de Contrato		Tipo de Ingreso: ☐ Remuneración Fija ☐ Remuneración Variable ☐ Honorarios	
Antigüedad en la Empresa ☐ Empleado ☐ Trabajador Dependiente ☐ Trabajador Independiente ☐ Familiar no Remunerado ☐ Trabajador Voluntario			
Categoría Ocupacional			
C. Datos del Accidente			
 Fecha del Accidente	☐ A.M. ☐ P.M. Hora del Accidente	☐ A.M. ☐ P.M. Hora de Ingreso al Trabajo	☐ A.M. ☐ P.M. Hora de Salida del Trabajo
 Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad)		 Comuna	
Señale qué estaba haciendo el trabajador al momento o justo antes del accidente:		Señale el lugar donde ocurrió el accidente (nombre de la sección, edificio, área, etc.):	
Describa ¿Qué pasó o cómo ocurrió el accidente?:			
Señale cuál era su trabajo habitual:		¿Al momento del accidente desarrollaba su trabajo habitual? ☐ SI ☐ NO	
Clasificación del Accidente (Ley 16.744): ☐ Grave ☐ Fatal ☐ Otro	Tipo de Accidente: ☐ Trabajo ☐ Trayecto	Si es accidente de Trayecto, responda:	
☐ Parte de Combustible ☐ Declaración ☐ Tránsito ☐ Otro		Tipo de accidente de Trayecto: ☐ Domicilio - Trabajo ☐ Trabajo - Domicilio ☐ Entre dos Trabajos	
Medio de Prueba		Detalle del Medio de Prueba	
D. Identificación del Denunciante			
 Nombre - Apellido Paterno - Apellido Materno		 RUT	
 Número de Teléfono		Clasificación del Denunciante (Ley 16.744): ☐ Empleado ☐ Trabajador/a ☐ Familiar ☐ Médico Tratante ☐ Comité Paritario ☐ Empresa Usaria ☐ Otro	
 Firma			

	PROTOCOLO DE MANEJO ANTE ACCIDENTES RELACIONADOS CON SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES DE RIESGO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTAS DE SALUD RURALES Y ESTACIÓN MÉDICO RURAL	Código:	RH 4.2
		Fecha:	Septiembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre 2030
		Página:	Página 14 de 14

Anexo 2: Formulario investigación incidente utilizado por Comité Paritario.

	SISTEMA DE GESTIÓN (SG) FORMULARIO	Revisión: 1 Página 1 de 2															
	INVESTIGACIÓN INCIDENTE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS																
<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>CENTRO DE TRABAJO</td> <td>FECHA</td> <td>HORA</td> <td>FECHA DIA1</td> </tr> <tr> <td colspan="5">LOGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OTROS ANTECEDENTES</td> </tr> </table>			CÓDIGO	CENTRO DE TRABAJO	FECHA	HORA	FECHA DIA1	LOGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE					OTROS ANTECEDENTES				
CÓDIGO	CENTRO DE TRABAJO	FECHA	HORA	FECHA DIA1													
LOGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE																	
OTROS ANTECEDENTES																	
TIPO ACCIDENTE ☐ INCIDENTE ☐ FALLA OPERACIONAL ☐ NAT ☐																	
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO: Nombre: _____ RUT: _____ Fecha de Nacimiento: _____ Edad: _____ Cargo: _____ TIPO DE CONTRATO: _____ Antigüedad en el Cargo: _____ Antigüedad en la Empresa: _____ Parte del cuerpo lesionado: _____ Nombre del Jefe Directo: _____ Cargo: _____ Recibió Charla Inducción / Trabajador Nuevo: ☐ Si ☐ No ☐ m/c ☐ Fecha: _____																	
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE (Cómo ocurrió) _____ _____ _____																	
CAUSAS INMEDIAS <table border="1"> <tr> <td> ACCIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Dejar de asegurar contra movimiento inesperado 2. ☐ Operar o trabajar a velocidad insegura 3. ☐ Dejar de advertir o señalar el riesgo 4. ☐ Usar herramienta o equipo inseguro 5. ☐ Usar de manera insegura herramienta en buen estado 6. ☐ Asumir posición o postura insegura 7. ☐ Ocuparse en juegos, distracciones o bromas 8. ☐ Dejar de usar elementos de protección personal 9. ☐ Desvirtuar de procedimiento de trabajo seguro recomendado 10. ☐ Reparar o dar servicio sin autorización a equipo peligroso 11. ☐ Actuar sin advertir el riesgo 12. ☐ Acción insegura de terceros 13. ☐ Sobreestimar capacidad física 14. ☐ Otros </td> <td> CONDICIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Limpieza Orden y limpieza 2. ☐ Objetos que sobresalen 3. ☐ Congestión o espacio libre insuficiente 4. ☐ Almacenamiento defectuoso 5. ☐ Herramientas o equipo defectuosos 6. ☐ Ropa personal peligrosa 7. ☐ Falta de elemento de protección personal 8. ☐ Elemento de protección personal inadecuado 9. ☐ Falta dispositivo de seguridad o señalización 10. ☐ Condición atmosférica peligrosa 11. ☐ Método inseguro de trabajo 12. ☐ Superficie de trabajo en mal estado 13. ☐ Otros </td> </tr> </table>			ACCIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Dejar de asegurar contra movimiento inesperado 2. ☐ Operar o trabajar a velocidad insegura 3. ☐ Dejar de advertir o señalar el riesgo 4. ☐ Usar herramienta o equipo inseguro 5. ☐ Usar de manera insegura herramienta en buen estado 6. ☐ Asumir posición o postura insegura 7. ☐ Ocuparse en juegos, distracciones o bromas 8. ☐ Dejar de usar elementos de protección personal 9. ☐ Desvirtuar de procedimiento de trabajo seguro recomendado 10. ☐ Reparar o dar servicio sin autorización a equipo peligroso 11. ☐ Actuar sin advertir el riesgo 12. ☐ Acción insegura de terceros 13. ☐ Sobreestimar capacidad física 14. ☐ Otros	CONDICIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Limpieza Orden y limpieza 2. ☐ Objetos que sobresalen 3. ☐ Congestión o espacio libre insuficiente 4. ☐ Almacenamiento defectuoso 5. ☐ Herramientas o equipo defectuosos 6. ☐ Ropa personal peligrosa 7. ☐ Falta de elemento de protección personal 8. ☐ Elemento de protección personal inadecuado 9. ☐ Falta dispositivo de seguridad o señalización 10. ☐ Condición atmosférica peligrosa 11. ☐ Método inseguro de trabajo 12. ☐ Superficie de trabajo en mal estado 13. ☐ Otros													
ACCIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Dejar de asegurar contra movimiento inesperado 2. ☐ Operar o trabajar a velocidad insegura 3. ☐ Dejar de advertir o señalar el riesgo 4. ☐ Usar herramienta o equipo inseguro 5. ☐ Usar de manera insegura herramienta en buen estado 6. ☐ Asumir posición o postura insegura 7. ☐ Ocuparse en juegos, distracciones o bromas 8. ☐ Dejar de usar elementos de protección personal 9. ☐ Desvirtuar de procedimiento de trabajo seguro recomendado 10. ☐ Reparar o dar servicio sin autorización a equipo peligroso 11. ☐ Actuar sin advertir el riesgo 12. ☐ Acción insegura de terceros 13. ☐ Sobreestimar capacidad física 14. ☐ Otros	CONDICIÓN INSEGURA / SUBESTANDAR 1. ☐ Limpieza Orden y limpieza 2. ☐ Objetos que sobresalen 3. ☐ Congestión o espacio libre insuficiente 4. ☐ Almacenamiento defectuoso 5. ☐ Herramientas o equipo defectuosos 6. ☐ Ropa personal peligrosa 7. ☐ Falta de elemento de protección personal 8. ☐ Elemento de protección personal inadecuado 9. ☐ Falta dispositivo de seguridad o señalización 10. ☐ Condición atmosférica peligrosa 11. ☐ Método inseguro de trabajo 12. ☐ Superficie de trabajo en mal estado 13. ☐ Otros																
OBSERVACIONES: _____ _____ _____																	

	SISTEMA DE GESTIÓN (SG) FORMULARIO	Revisión: 1 Página 2 de 2															
	INVESTIGACIÓN INCIDENTE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS																
CAUSAS BÁSICAS <table border="1"> <tr> <td> CAUSAS ORIGEN (Factor Personal) 1. ☐ Falta de conocimiento 2. ☐ Falta de capacidad física o mental 3. ☐ Falta de Motivación </td> <td> CAUSAS ORIGEN (Factor del Trabajo) 1. ☐ Diseño normal 2. ☐ Problemas de diseño 3. ☐ Deficiencia de mantención 4. ☐ Adquisición incorrecta 5. ☐ Falta de procedimiento o normas inadecuadas 6. ☐ Falta de Planificación 7. ☐ Otros </td> </tr> </table>			CAUSAS ORIGEN (Factor Personal) 1. ☐ Falta de conocimiento 2. ☐ Falta de capacidad física o mental 3. ☐ Falta de Motivación	CAUSAS ORIGEN (Factor del Trabajo) 1. ☐ Diseño normal 2. ☐ Problemas de diseño 3. ☐ Deficiencia de mantención 4. ☐ Adquisición incorrecta 5. ☐ Falta de procedimiento o normas inadecuadas 6. ☐ Falta de Planificación 7. ☐ Otros													
CAUSAS ORIGEN (Factor Personal) 1. ☐ Falta de conocimiento 2. ☐ Falta de capacidad física o mental 3. ☐ Falta de Motivación	CAUSAS ORIGEN (Factor del Trabajo) 1. ☐ Diseño normal 2. ☐ Problemas de diseño 3. ☐ Deficiencia de mantención 4. ☐ Adquisición incorrecta 5. ☐ Falta de procedimiento o normas inadecuadas 6. ☐ Falta de Planificación 7. ☐ Otros																
OBSERVACIONES: <table border="1"> <tr> <th>INSTRUCCIONES PARA EVITAR REPETICIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			INSTRUCCIONES PARA EVITAR REPETICIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO												
INSTRUCCIONES PARA EVITAR REPETICIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO															